

GUIA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE

Cuidados de Enfermería en Pacientes con Trastorno Psiquiátrico

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	TENS	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Cuidados de Enfermería en Pacientes con trastorno Psiquiátrico
CURSO		N° ACTIVIDAD	1
ASIGNATURA	CES4111	DURACIÓN	80 minutos (2 módulos)
FECHA		N° DE ALUMNOS	12 alumnos
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
1. Ejecutar los cuidados de enfermería pre y post-TEC en paciente con alteración psiquiátrica en fase de recuperación post-procedimiento. 2. Demostrar cuidados de enfermería en administración de fármacos en paciente con alteración psiquiátrica en contexto de atención ambulatoria 3. Realizar valoración integral en paciente con alteración psiquiátrica en contexto de atención ambulatoria			

3: INTRODUCCIÓN

Los trastornos psiquiátricos representan una preocupación creciente en la salud pública chilena. Según datos recientes, aproximadamente el 20% de la población en Chile experimentará algún trastorno de salud mental en algún momento de sus vidas, destacando la necesidad urgente de abordar estos desafíos.

Este panorama evidencia la importancia de que los profesionales de enfermería estén capacitados para brindar cuidados integrales, éticos y empáticos a pacientes con trastornos psiquiátricos. La atención de enfermería en salud mental no solo implica la administración de tratamientos, sino también la capacidad de establecer relaciones terapéuticas, identificar signos de crisis y aplicar intervenciones adecuadas que promuevan la estabilidad y el bienestar del paciente.

4: DESARROLLO DEL TEMA

Administración de Medicamentos en Pacientes con Alteración Psiquiátrica

La administración de psicofármacos en pacientes con alteraciones psiquiátricas representa un escenario clínico complejo, donde el juicio clínico del profesional de enfermería y sus habilidades comunicativas y relacionales son determinantes. En estos contextos, el conocimiento de los efectos secundarios, las técnicas seguras de administración y la comprensión de la experiencia subjetiva del paciente son fundamentales para brindar cuidados humanizados y efectivos.

Clasificación de Psicofármacos y Efectos Secundarios Comunes

1. Sedantes

Objetivo: Disminuir la actividad mental.

Incluyen: neurolepticos, ansiolíticos e hipnóticos.

Efectos secundarios frecuentes:

- Trastornos extrapiramidales: rigidez, distonía, discinesia tardía.
- Efectos anticolinérgicos: sequedad bucal, visión borrosa, retención urinaria.

- Efectos neurológicos: somnolencia, vértigo, ataxia, dificultad para concentrarse.
- Hipotensión ortostática.

2. Estimulantes

Objetivo: Aumentar la actividad mental.

Incluyen: antidepresivos y psicoestimulantes.

Efectos secundarios frecuentes:

- Insomnio, irritabilidad, inversión del ánimo.
- Delirio en pacientes psicóticos.
- Disartria, cefalea, estreñimiento.

3. Reguladores del estado de ánimo

Objetivo: Estabilizar oscilaciones anímicas.

Efectos secundarios frecuentes:

- Náuseas, vómitos, diarrea, sabor metálico.
- Temblor fino, poliuria, astenia, debilidad muscular.
- Confusión, hiperactividad o afasia.

Cuidados de Enfermería en la Administración de Psicofármacos

Además de aplicar los **5 correctos** de la administración de medicamentos (paciente, medicamento, dosis, vía, hora), en pacientes psiquiátricos se debe considerar especialmente:

- **Actitud y colaboración del paciente:** Las manifestaciones clínicas de su patología pueden influir directamente en su disposición a colaborar.
- **Comunicación terapéutica:** La elección de palabras debe adaptarse al estado mental del paciente para favorecer la adherencia y reducir la angustia.
- **Supervisión post-administración:** Verificar la deglución efectiva (en fármacos orales) o la técnica segura (en vía IM).

Caso Clínico 1 – Medicación oral en paciente paranoide

Paciente: Juan, 26 años, diagnóstico de esquizofrenia paranoide.

Indicación: Quetiapina 100 mg VO.

Situación: El paciente rechaza la medicación afirmando que “quieren matarlo”.

Intervención sugerida:

- Validar la emoción del paciente (angustia, miedo).
- Reformular el propósito del medicamento usando términos que no refuercen la idea de control o manipulación (“te ayudará con la angustia”, en lugar de “te ayudará con la paranoia”).
- Supervisar la ingesta efectiva conversando con el paciente y/o pidiendo que muestre la cavidad oral tras la toma.

Caso Clínico 2 – Medicación IM en paciente en fase maníaca

Paciente: Pedro, 35 años, diagnóstico de trastorno afectivo bipolar en fase maníaca.

Indicación: Clorpromazina 25 mg IM.

Situación: El paciente está agitado, rechaza la medicación, destruye mobiliario.
Intervención sugerida:

- Intentar inicialmente una aproximación verbal calmada, identificar causa de enojo y presentar el fármaco como apoyo al autocontrol.
- Si no se logra colaboración, intervenir con apoyo de otros profesionales.
- Evaluar riesgos: presencia del equipo puede aumentar presión, pero también puede disuadir comportamiento violento.
- En caso de requerir contención física, realizarla de forma segura y coordinada.
- Administrar la medicación rápidamente en músculo glúteo mayor (posición decúbito prono).
- Aplicar el **sexto correcto**: supervisión post administración y vigilancia de efectos adversos inmediatos.

Monitoreo de Efectos Secundarios: Acciones de Enfermería Clave

- Educación al paciente y familia sobre posibles efectos adversos.
- Estimular adecuada hidratación (2-3 litros/día).
- Orientación temporoespacial si hay desorientación.
- Enseñar levantada progresiva para prevenir hipotensión ortostática.
- Fomentar actividad diurna y descanso nocturno.
- Promover dieta rica en fibra para prevenir estreñimiento.
- Evaluar signos de contracturas o debilidad muscular.
- Observar signos de alteración del ánimo o agravamiento psicopatológico.

Toma de Muestra Sanguínea en Paciente con Agitación Psicomotora

Paciente: María, 43 años, diagnóstico de manía psicótica.

Procedimiento requerido: Litemia.

Situación: La paciente cree que “el pinchazo le robará sus habilidades mentales” y se niega al procedimiento.

Intervención sugerida:

- Intentar inicialmente una persuasión respetuosa, apelando a su bienestar.
- Si no se logra colaboración, informar sobre necesidad de contención física.
- Solicitar apoyo del equipo completo de enfermería.
- Aplicar técnica segura de contención y extracción de sangre venosa con rapidez y precisión.
- Proteger al paciente y al equipo durante el procedimiento.

Terapia Electroconvulsiva (TEC)

Antes de la TEC – Preparación de Enfermería

- Ayuno: sólidos (8 hrs), líquidos (4 hrs).
- Suspendir medicamentos según indicación (benzodiacepinas, anticonvulsivantes).
- Verificar consentimiento informado.

- Higiene corporal, retiro de objetos personales y prótesis.
- Control de signos vitales y eliminación vesical e intestinal.
- Valoración basal: estado cognitivo, emocional, físico.
- Uso de ropa institucional adecuada.
- Traslado a pabellón con vigilancia de conducta y riesgo de huida.

Durante la TEC

- Apoyo emocional durante el traslado y preparación.
- Coordinación con el equipo médico.
- Supervisión del procedimiento.

Después de la TEC – Cuidados Inmediatos

- Recepción del paciente y traslado seguro a cama.
- Control de signos vitales y estado neurológico.
- Valoración física: cefalea, mialgias, quemaduras en sienes, parestesia.
- Vigilar ayuno (mínimo 2 horas).
- Apoyar reinserción en actividades diarias del servicio.
- Educar sobre amnesia transitoria post-TEC.
- Registro continuo del estado general durante el resto del día.

1. Técnica: Preparación Preoperatoria de un Paciente con Indicaciones de TEC

Paso	Acción	Fundamento
1	Verificar indicación médica, consentimiento informado y documentación.	Garantiza la legalidad y el consentimiento informado del procedimiento.
2	Confirmar ayuno previo (mínimo 6 horas)	Previene riesgo de broncoaspiración bajo anestesia.
3	Retirar prótesis dentales, objetos metálicos, lentes y joyas	Evita riesgos de lesión o interferencia eléctrica.
4	Valorar signos vitales y registrar	Detecta alteraciones clínicas que contraindiquen el procedimiento.
5	Explicar de manera calmada el procedimiento al paciente	Disminuye ansiedad, favorece cooperación y confianza.
6	Canalizar vía venosa periférica (si corresponde)	Asegura acceso venoso para administración de anestésicos y medicación de urgencia.

2. Técnica: Ejecución de Cuidados de Enfermería Post-TEC

Paso	Acción	Fundamento
1	Posicionar al paciente en decúbito lateral seguro	Previene broncoaspiración en caso de vómitos o secreciones.
2	Controlar signos vitales inmediatamente y luego cada 15 minutos	Detecta precozmente complicaciones como arritmias, hipotensión o hipoxia.
3	Vigilar el estado de conciencia (nivel de alerta)	Identifica recuperación adecuada o deterioro neurológico.
4	Evaluar presencia de dolor, cefalea o desorientación	Maneja síntomas post-procedimiento que afectan recuperación.
5	Mantener ambiente tranquilo y brindar contención emocional	Minimiza confusión o agitación post anestesia y convulsión.
6	Informar cualquier alteración significativa al equipo médico	Asegura intervención oportuna y continuidad del cuidado.

3. Técnica: Administración de Medicamentos en Paciente Psiquiátrico

Paso	Acción	Fundamento
1	Verificar prescripción médica y cinco correctos (paciente, medicamento, dosis, vía, hora)	Evita errores de medicación.
2	Preparar el medicamento en condiciones asépticas	Mantiene seguridad y efectividad del fármaco.
3	Explicar al paciente qué medicación recibirá y su propósito	Promueve adherencia y reduce resistencia.
4	Administrar el medicamento respetando la vía indicada (oral, IM, IV)	Garantiza absorción y efecto adecuado del fármaco.
5	Vigilar posibles efectos adversos inmediatos	Permite intervención precoz ante reacciones adversas.
6	Registrar administración y observaciones	Asegura trazabilidad y continuidad de cuidados.

4. Técnica: Realizar Control de Signos Vitales (CSV) en Paciente con Alteración Psiquiátrica

Paso	Acción	Fundamento
1	Preparar el material necesario: esfigmomanómetro, termómetro, oxímetro, reloj con segundero	Garantiza ejecución fluida y sin interrupciones.
2	Abordar al paciente con actitud calmada y respetuosa	Reduce ansiedad y favorece cooperación.
3	Medir presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria, temperatura corporal y saturación de oxígeno	Permite valorar el estado hemodinámico y respiratorio.
4	Registrar cada parámetro inmediatamente	Evita omisiones o errores de memoria.
5	Reportar inmediatamente cualquier parámetro alterado	Permite actuar a tiempo para prevenir complicaciones.

6: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Servicio de salud mental Complejo hospitalario universitario de Albacete., 2007. *Protocolo de terapia electroconvulsiva (TEC)*
2. ALVAREZ, C. *Papel de enfermería en la evaluación y control de los efectos secundarios de los psicofármacos*. 1999
3. ARANCIBIA, R; GONZÁLEZ H., PÉREZ, C., ELGUETA, F. Anestesia en terapia electroconvulsiva (TEC). *Revista chilena de anestesia*. 43: 57-66. (2014)